

1. Introducción y relevancia clínica

La **crisis de ansiedad severa** —frecuentemente expresada como **ataque de pánico**— es una **aparición brusca** de miedo o malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos y se acompaña de un conjunto de **síntomas autonómicos** (palpitaciones, sudoración, disnea, dolor torácico, mareo, parestesias) y **cognitivos** (aprehensión, catastrofismo: “me voy a morir”, “me voy a volver loco”). Es una de las razones más habituales de consulta en **Servicios de Urgencia y APS** porque **simula condiciones médicas potencialmente letales** (síndrome coronario agudo, asma, ACV), lo que exige **triage y descartar orgánico apropiado** antes de confirmar su origen psicógeno.

Relevancia clínica:

- Alta **prevalencia** y recurrencia; impacto en calidad de vida, absentismo, uso de urgencias.
- **Comorbilidad** con depresión, consumo de sustancias y otros trastornos de ansiedad.
- **Riesgo iatrogénico**: sobrerreanimación o exámenes invasivos innecesarios si no se aplica un protocolo claro.
- En **EUNACOM**, los casos típicos plantean **dolor torácico + palpitaciones + sensación de muerte inminente** en adulto joven con exámenes normales, donde el desafío es **descartar causas médicas y indicar manejo sintomático y preventivo**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La crisis de ansiedad surge de una **activación aguda del sistema de respuesta al estrés** (eje **amígdala–hipotálamo–tronco**), con descarga simpática y **hiperventilación**.

Mecanismos clave:

- **Hiperactividad noradrenérgica** (locus coeruleus) → taquicardia, tremor, sudoración.

- **Hiperventilación:** $\downarrow$ $p\text{CO}_2$ $\rightarrow$ alcalosis respiratoria $\rightarrow$ **mareo, parestesias peribucuales y acrales, opresión torácica.**
- **Sesgos cognitivos:** atención selectiva a sensaciones interoceptivas benignas que se reinterpretan como **amenaza vital** (catastrofismo).
- **Condicionamiento:** lugares/estímulos asociados a crisis previas se convierten en **disparadores.**
- **Vulnerabilidad** genética/moduladores (SER, GABA).

Conceptos DSM-5-TR:

- **Ataque de pánico:** episodio paroxístico con ≥ 4 de 13 síntomas (ver clínica), de inicio súbito y pico en minutos.
- **Trastorno de pánico:** ataques recurrentes e **inesperados** + **ansiedad anticipatoria** o conductas de evitación ≥ 1 mes.
- **Agorafobia:** miedo/evitación de lugares donde escapar o recibir ayuda sería difícil (transporte, multitudes).

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Presentación típica (en urgencia)

- **Inicio abrupto** durante reposo o estrés menor.
- **Síntomas físicos:** palpitaciones, taquicardia, opresión o dolor torácico, disnea, sensación de ahogo, náuseas, sudoración, temblor, mareo, inestabilidad, parestesias, escalofríos/bochornos.
- **Síntomas cognitivos:** miedo a morir, perder el control o “volverse loco”, desrealización/despersonalización.
- **Curso:** alcanza **máxima intensidad en 10–15 min**, dura habitualmente < 60 min, deja **fatiga postcrisis.**

3.2. Criterios de ataque de pánico (DSM-5-TR)

Aparición súbita de miedo/malestar intenso con ≥ 4 de los siguientes:

1. palpitaciones/taquicardia, 2) sudoración, 3) temblor, 4) disnea, 5) sensación de atragantamiento, 6) dolor/opresión torácica, 7) náuseas/malestar abdominal, 8) mareo/aturdimiento, 9) escalofríos/bochornos, 10) parestesias, 11) desrealización/despersonalización, 12) miedo a perder el control/enloquecer, 13) **miedo a morir**.

3.3. Señales de alarma (“red flags”)

Indican **prioridad de descartar causa orgánica**:

- Primera crisis en **>45 años** o **comorbilidad cardiovascular** relevante.
- Dolor torácico **prolongado** o desencadenado por **esfuerzo**.
- Sincope, déficit neurológico focal, fiebre, trauma, **hipoxia**.
- Consumo de **cocaína/anfetaminas** o **abstinencia** alcohólica/benzodiacepínica.
- **Embarazo** o **posparto** inmediato.
- **Tirotoxicosis** u otras endocrinopatías.

3.4. Diagnóstico diferencial esencial

Entidad	Claves diferenciales
SCA/angina	Dolor torácico opresivo con esfuerzo, ECG/troponinas alterados.
Tromboembolismo pulmonar	Disnea súbita, taquicardia, hipoxemia, riesgo trombótico.
Asma/crisis respiratoria	Sibilancias, respuesta a broncodilatadores.
Arritmias	Palpitaciones irregulares persistentes, hallazgos en ECG/monitor.

Hipertiroidismo/feocromocitoma	Pérdida de peso, bocio, hipertensión paroxística.
Hipoglicemia	Diaforesis, confusión; glicemia baja.
Intoxicación estimulantes	Midriasis, HTA marcada, hipertermia.
TEPT/ansiedad	Crisis en contexto de estímulos traumáticos; no descarta comorbilidad médica.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Enfoque práctico en Urgencia (protocolo breve)

1. **Signos vitales + glicemia capilar + oximetría.**
2. **ECG 12 derivaciones** en todo dolor torácico/taquicardia.
3. Según contexto: **troponinas, gases, electrolitos, TSH, embarazo, D-dímero** (regla de Wells), radiografía de tórax.
4. **Tóxicos en orina** si se sospecha estimulantes o policonsumo.
5. Si hay **neurológicos focales**, fiebre o cefalea atípica → **TAC/punción lumbar** según clínica.

Cuando **no hay red flags y los estudios iniciales son normales**, se favorece el diagnóstico de **crisis de ansiedad/ataque de pánico**.

4.2. Criterios diagnósticos (resumen)

- **Ataque de pánico:** criterios DSM-5-TR cumplidos.
- **Trastorno de pánico:** ataques **inesperados y recurrentes + ansiedad anticipatoria/evitación ≥1 mes**, con repercusión funcional.

- **Crisis de ansiedad secundaria:** si se explica mejor por **sustancia** (cocaína, anfetaminas), **condición médica** (hipertiroidismo, feo) o **otro trastorno mental**.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo se estructura en **tres niveles**: (A) **desescalada inmediata** de la crisis, (B) **tratamiento agudo farmacológico/conductual**, y (C) **plan de continuidad** (psicoeducación, TCC, farmacoterapia de mantención cuando corresponde).

5.1. Intervención inmediata (en el box)

- **Explicar y nombrar:** “Está teniendo una **crisis de ansiedad**. Es **molesta pero no peligrosa**; va a pasar”.
- **Respiración guiada:** ritmo 4-4-6 (inspirar 4 s, pausar 4 s, exhalar 6 s), 3–5 minutos.
- **Postura y ambiente:** sentar al paciente, lugar silencioso y ventilado, evitar aglomeración.
- **Reentrenamiento respiratorio** si hiperventila (evitar bolsa cerrada de rutina; preferir instrucción guiada).
- **Evitar** frases invalidantes (“cálmese”), preferir **validación** (“entiendo que asusta; vamos a acompañarle”).

Estas medidas por sí solas reducen la intensidad en **5–10 minutos** en la mayoría de los casos.

5.2. Manejo farmacológico agudo (si no cede con medidas no farmacológicas)

Objetivo: cortar el círculo miedo-hiperventilación-síntomas, reducir angustia y permitir reevaluación.

- **Benzodiacepinas de vida media intermedia/corta**
 - **Lorazepam** 1–2 mg **SL/VO**; repetir 1 mg a los 15–20 min si no cede (máx 4 mg en urgencia).
 - **Clonazepam** 0,25–0,5 mg **SL/VO**; útil si hay crisis más prolongada (máx 1 mg).

- **EV/IM** solo si no tolera VO o hay agitación intensa (monitorear sedación y saturación).
- **Precaución: embarazo, EPOC, apnea del sueño, ancianos;** evitar en intoxicación alcohólica.
- **Antihistamínicos sedantes** (alternativa cuando se evita BZD):
 - **Hidroxicina** 25–50 mg VO.
- **Evitar** antipsicóticos de rutina (no son de elección salvo agitación con ideas delirantes comórbidas).

En consumo de estimulantes, la **benzodiacepina** es primera línea; **evitar betabloqueadores** no selectivos (riesgo vasoespasmo).

5.3. Alta segura desde urgencia

Con estudios normales y buena respuesta clínica:

- **Explicar el diagnóstico** y el **modelo fisiológico** (hiperventilación/alcalosis).
- Entregar **técnicas de respiración** por escrito y **plan de exposición interoceptiva** básico (ver más abajo).
- Dejar **rescate por pocos días** si hay recurrencia nocturna o impacto laboral (p. ej., **lorazepam 0,5–1 mg SL, máx 10 comprimidos**, instruyendo **no conducir**).
- **Derivar a APS/salud mental** en ≤7–14 días para **TCC** e iniciar si corresponde **ISRS**.
- **Educación** sobre cafeína, nicotina, alcohol y sueño.
- Señalizar “**signos de alarma**” para reconsulta (dolor torácico persistente, síncope, fiebre, focalidad, consumo de estimulantes).

5.4. Tratamiento de continuidad (prevención de recaídas)

A) Psicoeducación + TCC (primera línea)

- **Modelo psicoeducativo:** círculo pánico → hiperventilación → síntomas → interpretación catastrófica → más pánico.
- **Entrenamiento respiratorio** diario (4-6 semanas).

- **Exposición interoceptiva:** provocar sensaciones temidas y reatribuir (p. ej., hiper-respirar 60 s, girar en la silla 30 s, subir escaleras) **en contexto controlado**.
- **Exposición in vivo** (si hay agorafobia): gradiente de situaciones evitadas (transporte, filas, supermercados).
- **Reestructuración cognitiva:** identificar pensamientos automáticos (“infarto”) y reemplazarlos por interpretaciones realistas (“síntomas benignos del pánico”).
- **Prevención de recaídas:** señales tempranas, plan de afrontamiento escrito.

B) Farmacoterapia de mantenimiento (si Trastorno de Pánico, comorbilidad o fracaso de TCC sola)

ISRS (de elección):

- **Sertralina:** 25 mg/día por 1 semana, luego 50–100 mg/día (rango: 50–200).
- **Escitalopram:** 5 mg/día, luego 10–20 mg/día.
- **Fluoxetina:** 10 mg/día, luego 20–40 mg/día (ojo activación inicial).

Otros:

- **SNRI** (venlafaxina 37,5–150 mg/día) si respuesta parcial a ISRS.
- **Evitar** tricíclicos en primera línea por tolerabilidad y seguridad.

Pautas:

- Informar **latencia de efecto** (2–4 semanas) y **titulación lenta** para minimizar activación.
- Mantener **6–12 meses** tras remisión completa, luego **retiro gradual**.
- **BZD** solo **corto plazo** (2–4 semanas) como **punteo** al ISRS/TCC; plan de **taper** definido.

C) Intervenciones de estilo de vida

- **Cafeína:** suspender o reducir significativamente (café, bebidas energéticas, “pre-workout”).
- **Nicotina:** cesación o reemplazo; la abstinencia aguda puede exacerbar ansiedad.

- **Sueño:** higiene estricta; tratar insomnio (TCC-I; considerar melatonina).
 - **Ejercicio aeróbico:** 150 min/semana; mejora ansiedad basal y sueño.
 - **Alcohol:** evitar su uso “ansiolítico” (empeora ansiedad de rebote).
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- **Cronificación** hacia **trastorno de pánico** (ataques inesperados + evitación).
- **Agorafobia** con discapacidad severa (evita locomoción colectiva, centros comerciales).
- **Comorbilidad:** depresión, abuso de alcohol/benzodiacepinas, trastornos somatomorfos.
- **Iatrogenia:** dependencia a BZD, consultas repetidas a urgencias y poliexamen.
- **Riesgo suicida:** bajo en la crisis aislada, **mayor** si coexiste **depresión**, consumo de sustancias o pánico crónico.

Pronóstico

- Con **TCC ± ISRS**, **60–80%** alcanza remisión o mejoría significativa en 8–12 semanas.
 - Factores de buen pronóstico: inicio claro, motivación para TCC, baja evitación, adherencia.
 - Mal pronóstico: evitación agorafóbica marcada, comorbilidad depresiva, dependencia de BZD, consumo de estimulantes.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. En **dolor torácico + palpitaciones**, haga **ECG** y descarte **SCA** antes de etiquetar “ansiedad”.
2. **Hiperventilación** explica **parestesias peribucales y de manos**; instruir **exhalación prolongada** (4-4-6).
3. **Lorazepam SL** (1–2 mg) es **útil, rápido y seguro** en el box si no hay intoxicación por alcohol/sedantes.
4. **TCC con exposición interoceptiva** es la **terapia más eficaz** para prevenir recaídas.
5. **ISRS** (sertralina/escitalopram) son **primera línea** en trastorno de pánico; educar sobre **latencia**.
6. **Evite BZD crónicas**: use por corto plazo y con **plan de suspensión** desde el día 1.
7. Investigue **cafeína/energéticos** y **consumo de estimulantes** en toda crisis.



Errores comunes

- Dar **alta** sin **explicar** fisiología y **plan de manejo** (favorece reconsultas).
- Indicar **benzodiacepinas indefinidas** “a demanda”.
- No **descartar** causas orgánicas **cuando hay red flags**.
- Iniciar **ISRS en dosis altas** (empeoran ansiedad inicial).
- No programar **seguimiento** ni derivación a **TCC**.
- Tratar crisis asociadas a **estimulantes** con antipsicóticos como primera línea (la **BZD** es prioritaria).

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **crisis de ansiedad severa** es un episodio **abrupto** y **autolimitado** que **imita** urgencias médicas; siempre descarte **red flags** (ECG en dolor torácico).

2. El **manejo agudo** comienza con **psicoeducación + respiración guiada**; si persiste, usar **lorazepam SL/VO** a bajas dosis.
3. Para prevenir recurrencias, la **TCC con exposición interoceptiva** es el tratamiento **más efectivo**; añada **ISRS** si hay **trastorno de pánico** o impacto funcional.
4. **Evite benzodiacepinas crónicas**; si se usan de rescate, **máx 2–4 semanas** con **taper planificado**.
5. Educar en **gatillantes** (cafeína, privación de sueño, estimulantes) y reforzar **higiene del sueño y ejercicio**.
6. Derivar a **APS/salud mental** para seguimiento en **≤2 semanas** tras la crisis.
7. Reconsidere etiologías médicas ante **cambios atípicos** o **síntomas persistentes** pese a manejo estándar.